



Servicio
de Salud
Araucanía Sur
Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Orientaciones para la programación 2026 DSSAS

Red asistencial de Araucanía Sur

01/11/2025

Contenido

Introducción	3
Ítem I “Directrices DSSAS”	4
Flujo para la programación médica y no médica	4
Flujograma de la programación médica y no médica	7
Validación planilla de programación	9
Recomendaciones para la programación de jefaturas	10
Desglose de actividades para profesionales en funciones administrativas	11
Indicaciones según horas contratadas	12
Estandarización de horas para contralor y priorizador	13
Profesionales que dan apoyo a una especialidad	14
Plan de trabajo con las especialidades priorizadas	15
Otras directrices	15
Ítem II “Material de apoyo”	16
OOTT 2026 y Recomendaciones programáticas específicas (RPE)	16
Glosario rendimiento normado por DSSAS	17
Lista de contactos con referencias involucradas en programación	17
Ítem III “Calendarización año 2026”	18
Programación inicial 2026	18
Primera Reprogramación 2026	18
Segunda Reprogramación 2026	19
Ítem IV “Anexos”	20
Documentos de apoyo	20
Formatos	20

Introducción

La programación, es la metodología con la que se define el cálculo de las actividades que debe cumplir un profesional de acuerdo con sus horas contratadas, los requerimientos de la especialidad y demanda local de cada establecimiento. Su objetivo es la optimización del recurso en base a la oferta (horas) disponible. Es por ello que la correcta programación de los profesionales ajustada a los lineamientos nos permite tener una herramienta de gestión para la toma de decisiones, nos ayuda a conocer la brecha, periodos críticos sanitarios, entre otros.

La programación se constituye como un proceso articulado entre distintos actores y para su éxito debe existir un trabajo coordinado entre todos quienes la componen, equipos directivos, jefaturas, coordinadores, y clínicos que hacen posible cubrir la demanda local. Lo anterior solo es factible si cada establecimiento difunde y hace partícipe a cada profesional su respectiva programación, dejando claro lo que se espera de cada uno; así como también supervisando mes a mes el cumplimiento y definiendo estrategias de mejora en caso de requerir intervenciones ajustadas al dinamismo del funcionamiento de los establecimientos.

En este contexto para el ciclo 2026 se está dando un enfoque de acompañamiento a los establecimientos y entrega de orientaciones enfocadas en hacer más sencillo el proceso de programación. Para ello, se consideraron las peticiones de los comités de programación de cada hospital y se complementaron las orientaciones técnicas 2026 con el fin de alinear los esfuerzos en un mismo objetivo.

Durante este año se irán evaluando las mejoras y cambios propuestos, ajustados a la participación con los establecimientos, facilitando la comunicación y trabajo coordinado entre la Dirección de Servicio, los Hospitales y dispositivos de la red.

Ítem I “Directrices DSSAS”

Las Orientaciones a nivel Dirección de Servicio de Salud Araucanía Sur establecen estándares para la gestión, organización y realización de la Programación Operativa de cada establecimiento de la RED. Su implementación contribuye a optimizar recursos, fortalecer la coordinación entre profesionales, mejorar los flujos de comunicación e información.

A continuación, se detallan las directrices fundamentales:

Flujo para la programación médica y no médica

A continuación, se detalla el flujo que debiera desarrollarse para la programación operativa de cada establecimiento, esto con el fin de lograr la participación de todos los involucrados en el proceso, reflejando la realidad local. **El SDM posee dentro de sus funciones el ser responsable de que se cumpla cada paso**, entendiendo la relevancia de lograr una programación eficiente.

Parte 1 (Establecimiento): Definición de prioridades, análisis del año anterior y programación preliminar.

- Recepcionadas las OOT ministeriales – DSSAS y el cronograma con los plazos del proceso, el comité de programación local se debe reunir para definir las prioridades del establecimiento ajustado a lo indicado en las OOT.
- Realizar un análisis de la producción del año anterior, identificando las variables que impactan significativamente y las dificultades de seguir lo planificado.
- Recepción de consolidado con dotación del período a programar preparado por Subdirección de Gestión de las personas de la Dirección de Servicio de salud con la descarga desde SIRH según la fecha de corte. Una vez recibida esta información, el referente de cada establecimiento ligado a RRHH deberá traspasar lo correspondiente a su hospital. Una vez finalizado corresponderá enviar a SDM junto al encargado de programación.
- El SDM junto al encargado de programación se deberán reunir con las jefaturas de las especialidades y estamentos para:
 - Realizar análisis del año anterior
 - Revisión de antecedentes para el proceso en curso (Dotación, horas disponibles, comisiones, reemplazos, entre otros)
 - Definir el objetivo para la especialidad
 - Establecer los plazos para la entrega de planificaciones.
- Los jefes de especialidades/estamentos se deben reunir con sus equipos de trabajo, revisar la producción esperada para distribuir las horas acordes a los lineamientos y necesidades locales para dar respuesta al objetivo sanitario sumado a la resolución de lista de espera.
- Los jefes de especialidades/estamentos se deben reunir con el SDM y encargado de programación, con el fin de presentar una propuesta preliminar de la programación de los profesionales a su cargo.
- El SDM junto al Director deberán revisar las propuestas y decidir si se validan o si hay observaciones.

- Se validan: Deben enviar las propuestas al encargado de programación para ser ingresadas en la planilla.
- No se validan: Deben regresar las propuestas a los jefes con las observaciones realizadas para su corrección, una vez corregidas, se debe repetir el proceso.
- Traspasadas las propuestas a la planilla, el SDM es el responsable de enviar la planilla de programación vía correo a los referentes en la dirección de servicio.

Parte 2: Revisión (Dirección de Servicio)

- Recepcionadas las planillas de programación de todos los establecimientos se inicia con el cruce de información para la revisión.
- Se comparte un consolidado de todos los establecimientos a los referentes técnicos de la DSSAS para facilitar la revisión.
- Se elabora un informe por establecimiento, evaluando los criterios mínimos de validación.
- Recepcionadas las observaciones de los Ref. técnicos, se incorporan en el informe correspondiente.
- Terminada la revisión, se envían las observaciones al SDM del establecimiento con copia al encargado de programación, Director, y en caso de ser necesario a representante de RRHH u otros profesionales vinculados al proceso.

Parte 3 (Establecimiento): Correcciones

- Recepcionado el informe de observaciones, se debe reunir el Director, SDM y encargado de programación, con el objetivo de revisar y corregir o justificar lo analizado por los referentes.
- El SDM debe enviar la planilla a los referentes de programación con las correcciones realizadas o en caso de justificar alguna observación, deberá adjuntar el respaldo correspondiente (ver anexo Formatos N°5).
- (DSSAS) Enviará pauta de validación de planilla a cada establecimiento:
 - De ser validada, se enviará a Minsal.
Se informará al establecimiento desde Referente de Programación que su planilla ha completado el proceso.
 - De no ser validada, no será enviada a Minsal.
Se deberán hacer los ajustes necesarios para cumplir con los criterios mínimos de validación para el siguiente proceso de reprogramación. Posterior a ello se volverá a revisar la planilla para ser entregada en la etapa de corte siguiente si cumple con las correcciones.

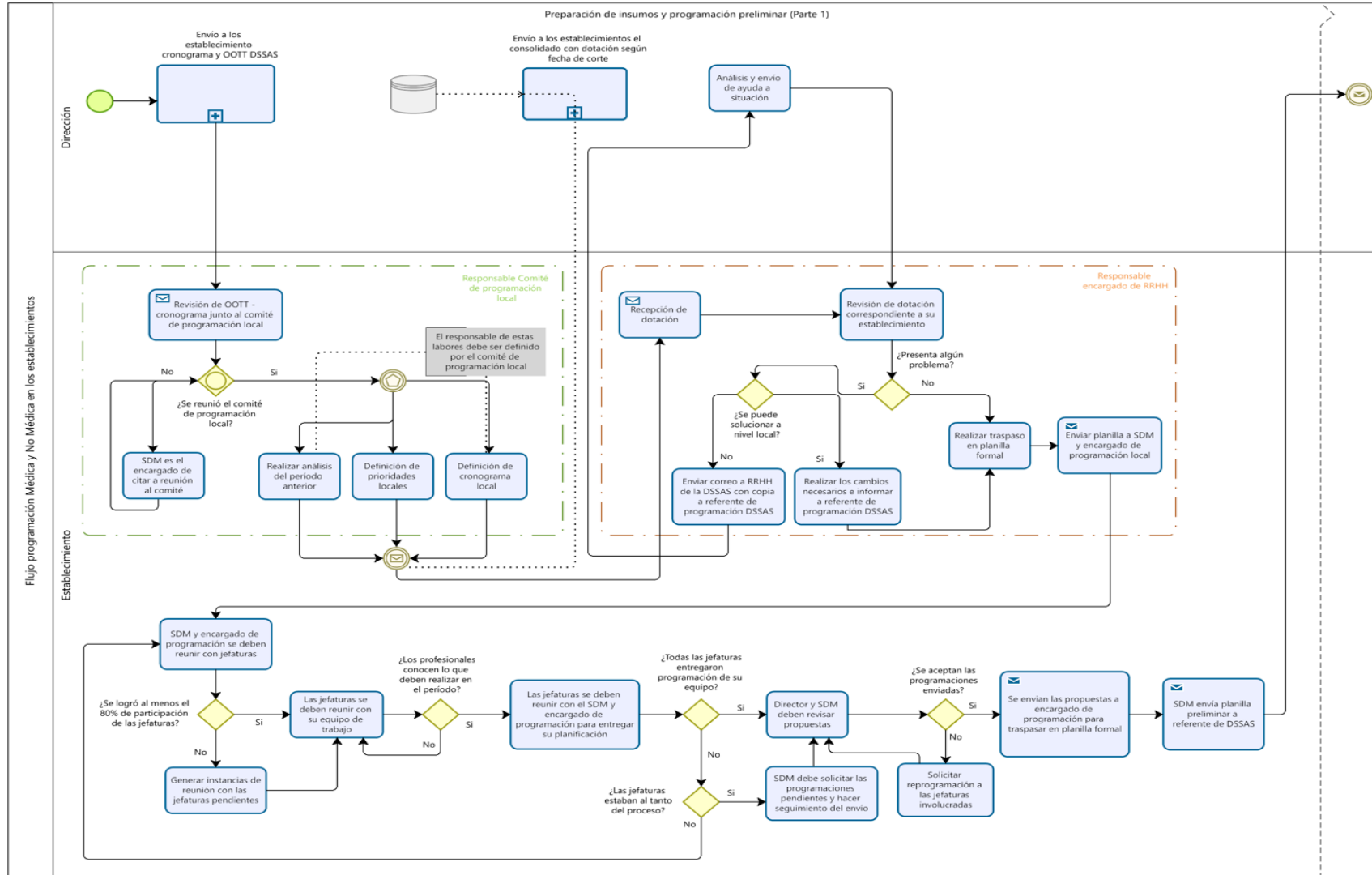
Parte 4 (Establecimientos): Seguimiento

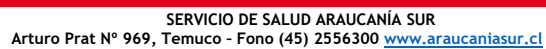
- El SDM deberá realizar un seguimiento continuo del cumplimiento de la programación. De este monitoreo pudieran desprenderse las siguientes situaciones:

1. Cada profesional conoce su programación y esta se ajusta a las necesidades del establecimiento, por lo que se obtiene un cumplimiento esperado.
2. Se obtiene un cumplimiento inferior a lo esperado: Se debe identificar la causa y definir estrategias de mejora, teniendo un acompañamiento más estricto.
3. Se presenta una contingencia que afecta a la programación esperada: Se deberá realizar un ajuste en la distribución de horas y actividades en los profesionales, siempre priorizando la atención del paciente. (Posibles contingencias: renuncia de profesionales, emergencia sanitaria, reducción de lista de espera, priorización del proceso quirúrgico). Recordar reunir evidencias, de modo que se tenga un respaldo para el proceso de apelación. Asimismo, revisar que no existan variables asociadas al registro o tributación inadecuada.
4. Se obtiene un cumplimiento superior a lo esperado: Revisar si se debe a variables no consideradas en el proceso de programación, como el aumento de horas de los especialistas, nuevas contrataciones y/o retorno de licencias médicas. En caso de no cumplirse alguna de las anteriores razones, evaluar la realización de una programación a la baja.
 - El comité de programación local deberá brindar apoyo al SDM en el seguimiento, por medio de análisis realizados en conjunto, dar señales de alerta frente a indicadores bajos, toma de decisiones frente a contingencias, entre otros.
 - El comité de programación local deberá reevaluar la última programación realizada e iniciar nuevamente el proceso cada trimestre.

Nota: En caso de necesitar orientación, apoyo en la revisión de planilla, seguimiento, acompañamiento in situ y/o capacitaciones, solicitar asesoría a referentes de programación.

Flujograma de la programación médica y no médica





Validación planilla de programación

A continuación, se muestran los criterios mínimos para la validación de la planilla de programación enviada por cada establecimiento, además de otros sugeridos para la eficiencia del proceso, los cuales a medida que se vaya avanzando en la implementación esperada del proceso, se irán actualizando y/o modificando acorde a las necesidades institucionales.

En anexo Formatos N°1 se encuentra pauta de cotejo que será enviada post periodo de correcciones, en donde se les indicará el estado de su programación (Validada o No validada).

Criterios obligatorios de validación

- **SDM envía planilla en formato y tiempo** ajustado al cronograma informado por parte de la Dirección de Servicio.
- **Envío de actas de reunión de comité de programación y lista de asistencia con más del 50% de los integrantes por resolución y/o subrogantes:** Tal como se indicó anteriormente, es imperativo relevar la importancia de la reunión entre todos los actores que se ven involucrados directa o indirectamente en el proceso, mejorando la comunicación y el flujo de información. Esto ayudará a clarificar las necesidades del establecimiento y optimizar el uso de horas. Además, para la primera programación del proceso se solicitará validar a los integrantes del comité de programación vigentes. En aquellas resoluciones que no se cuenta con la denominación por cargo, se enviará un certificado anexo detallando quien desempeña la función para ese periodo. (ver anexo Formatos N°2)
- **Envío de certificado de RRHH:** Es exigencia por parte del nivel central adjuntar el certificado de cada establecimiento, el que debe ser enviado por el encargado de RRHH post periodo de correcciones (Con copia al SDM de su hospital). En anexo Formatos N°3 encontrarán el formato compartido por Minsal. Esta responsabilidad recae en cada establecimiento y deberá asegurarse por parte del SDM su cumplimiento.
- **Envío de lista de participación de jefaturas de especialidades priorizadas:** Revisar ítem “Plan de trabajo con las especialidades priorizadas”.
- **Validación por referencias técnicas de la DSSAS:** En anexo Formatos N°7 encontrarán pauta de revisión para las referencias de la DSSAS definida por el equipo de programación. Los referentes técnicos son los encargados de validar estamentos y/o especialidades de acuerdo a sus áreas técnicas. Se considera cumplido este punto considerando las pautas recepcionadas de los referentes que participen en el periodo en evaluación.
- **Rendimientos indicados en especialidades con acuerdo a nivel RED:** Se revisará el cumplimiento en los rendimientos indicados en las especialidades de Medicina Interna, Pediatría y Traumatología. Se trabajará con los referentes del servicio para nuevos acuerdos a nivel central. No se validará ningún cambio de rendimiento local en el establecimiento que no haya sido aprobado por el Comité de programación de la DSSAS.
- **Correcciones realizadas y/o justificaciones enviadas:** Se corroboran los cambios solicitados, o en caso de realizar justificaciones, se revisará su pertinencia para validación.

- **Programación de médicos generales:** Se revisará en planilla la columna de MG, tal como se indica en el ítem de profesionales que apoyan a una especialidad. Los establecimientos no podrán tener en blanco esta columna, al tener en conocimiento que tienen profesionales apoyando.
- **Compromiso de programación por Director y SDM del hospital:** Después de las correcciones, se enviará a cada establecimiento un resumen de la programación, el cual deberán firmar y remitir vía correo electrónico a referente de programación DSSAS (ver anexo Formatos N°4) Esto se realiza con el fin de involucrar a los equipos directivos respecto del compromiso que deben asumir al enviar una programación y su posterior seguimiento en el cumplimiento.

Criterios sugeridos a considerar en el proceso

- **Programación de actividades trazadoras:** Se estableció este criterio considerando los siguientes puntos:
 - N° horas según dotación
 - N° horas ambulatorias según N° de box clínicos
 - N° de horas del proceso quirúrgico según N° de horas en trabajo de pabellones
 - N° de horas de proceso hospitalizados según N° de camas por nivel de cuidados
 - Producción semestre anterior para la especialidad.

Importante: En caso de permanecer constantes estos aspectos de un proceso a otro, y se realice una programación menor al año anterior, no se validará la programación del establecimiento.

- **Porcentaje de horas asignadas al proceso ambulatorio por especialidad:** Se espera lograr el porcentaje de acuerdo a norma ministerial, de momento se considerará criterio sugerido, sin embargo, en los siguientes procesos será obligatorio.
- **Cumplimiento del 100% de las OOTT ministeriales y DSSAS**

Recomendaciones para la programación de jefaturas.

Este apartado tiene el fin de ordenar y conocer aquellos profesionales que asumen funciones de jefatura en los establecimientos, además de equilibrar la asignación de horas no clínicas. Es por ello que a continuación se presentan limitaciones para la programación de actividad "Gestión Organizacional (Administrativo/Jefatura)":

- Solo las jefaturas con resolución pueden tener programada esa actividad. No se le debe programar a los subrogantes.
- Se considerarán horas de Gestión Organizacional sólo para jefes de servicio, supervisores de unidad y programas que se encuentren reconocidos en el organigrama del establecimiento. Jefaturas de equipo no podrán optar a horas de esta actividad. Si pudieran contar con horas administrativas para procesos asociados a su ámbito de acción.

- Un especialista con contrato de 11 horas no podrá optar a funciones de jefatura de especialidad.
- En especialidades con profesional único, no se puede asignar horas de jefatura.
- No se debe asignar horas de esta actividad a jefes de subespecialidades.
- De manera excepcional si el establecimiento decidiera algún cambio deberá notificarlo por oficio o no será validado por equipo de programación DSSAS.

El máximo de horas destinadas a la actividad ya mencionada se estandarizó según los cargos y responsabilidades.

- Subdirector médico: Se podrá destinar un máximo de 22 a 33 horas en actividades no clínicas.
- Jefe CCRR/CDT/CAE/Proceso ambulatorio: En los contratos de 44 horas o menos, podrán destinar el 50% de sus horas para labores administrativas. En los contratos de 50 horas, podrán destinar la totalidad del contrato de 22 horas.
- Jefe de servicio: No deberá superar el 25% de sus horas contratadas.
- Jefe de unidad: No deberá superar el 5% de sus horas.
- Jefe de programa: No deberá superar 1.5 horas semanales.

En casos excepcionales esto podría variar, pero deberá ser respaldado por el Director y SDM del establecimiento. No obstante, no se podrá destinar el 100% de su contrato de acuerdo a las orientaciones de programación.

No podrá destinarse el 100% de las horas contratadas a la actividad "Gestión Organizacional (Administrativo/Jefatura).

Desglose de actividades para profesionales en funciones administrativas

No se podrá destinar el 100% o gran parte de un contrato a una actividad, sin embargo, para aquellos profesionales clínicos que se desempeñan en funciones mayormente administrativas, tales como:

1. Dirección del establecimiento
2. Subdirectores
3. Coordinación de SOME/OIRS
4. Coordinación Matronería y Gestión del cuidado
5. Clínicos asociados a GRD, IAAS, Calidad
6. Psicología organizacional
7. Delegada/o de epidemiología
8. Otras áreas administrativas informadas por el establecimiento durante el envío de la planilla para validación

Podrán programar las siguientes actividades:

- Actividades de cuidado del equipo
- OANC Actividades administrativas
- OIRS
- OANC Administración de personal
- OANC Comité de apoyo a la gestión
- Gestión Organizacional (Administrativo/Jefatura)
- Reunión técnica administrativa

Nota: Se solicitará la incorporación de actividades específicas para algunos de los cargos mencionados anteriormente.

Indicaciones según horas contratadas

Se realiza revisión respecto de la asignación de horas administrativas, entregando orientaciones para las actividades vinculadas a estas funciones, y la distribución de horas por proceso de acuerdo a las horas de contrato de los profesionales, siempre con la finalidad de **priorizar la atención clínica del paciente**.

1. Contratos de 11 horas o menos y/o profesionales con concentración de horas:

- Estos profesionales no podrán optar a cargos de jefaturas, dado que se busca priorizar la asignación de sus horas con la atención directa del paciente.
- El máximo de horas asignadas a actividades administrativas será del 30% (por ejemplo 3.3 hrs para contratos de 11 hrs), debiendo cumplir el 70% de su jornada en atención ambulatoria y/o en el proceso quirúrgico (7.7 hrs).
- No se considerarán horas para visitas a sala según tipo de cama, a excepción de aquellos profesionales únicos de la especialidad.
- Si el profesional no asiste al establecimiento el día que se desarrollen reuniones clínicas y/o técnicas administrativas de la especialidad, no se les debe programar esta actividad.

2. Contratos de 22 horas:

- En caso de contar con un contrato 22/28 deberá cargarse el tiempo de colación a uno de ellos.
- De tener un contrato exclusivo de 22 hrs no tendrá derecho a colación.
- De tener dos contratos de 22 hrs sólo se deberá aplicar descuento por colación en uno de ellos.

3. Contratos de 28 horas:

- Solo podrán estar asociados a actividades de turno hospitalizados/urgencias/pabellón.
- En el caso de los liberados de guardia, se programarán 22 horas efectivas en el centro, de las cuales 7 deben ser exclusivas para labores de investigación, asesoría técnica y/o docencia.

- No podrá realizarse descuento de horas por concepto de colación o actividades del ámbito ambulatorio.

4. **Contratos de 33 - 44:**

- Corresponde para los contratos de 44 hrs descuento de 2.5 hrs a la semana por concepto de colación.
- En caso de tener un contrato de 11 y otro de 33 hrs // dos contratos de 11 y uno de 22 hrs, deberá asignar este tiempo al de mayor carga horaria.

Recordar que la programación nos entrega datos semanales, no especifica qué día se realizarán las actividades, por lo que es responsabilidad de cada profesional enviar a su jefatura la distribución mensual, **dentro de los últimos 5 días hábiles del mes anterior.** La jefatura directa tendrá que cerciorarse de recibir la planificación de cada persona a su cargo, y posteriormente deberá enviar a encargada/o de creación de agendas para realizar la de cada uno. Si es definición del establecimiento podrá enviarlo directamente a la persona encargada, previa validación de su jefatura y con copia a esta vía correo electrónico.

Cabe destacar que no está permitido que un profesional, independiente de sus horas contratadas, solicite el cambio de su programación fuera de los periodos definidos como “reprogramación”; se podrá realizar solo una vez cada semestre del año en curso. Los tiempos para este proceso, serán informados con anticipación. **En casos excepcionales, esto podrá ser validado por jefatura directa y SDM del establecimiento.**

Estandarización de horas para contralor y priorizador

De acuerdo con protocolo de referencia y contrarreferencia (ver anexo Documentos de apoyo N°4), las funciones de contralores y priorizadores se definen como:

- ❖ **Contralor:** *“Médicos, odontólogos y matrones/as responsables de revisar las derivaciones a especialidad (no GES) que se han originado dentro de su establecimiento, verificando la completitud de los datos administrativos y clínicos, fundamentos diagnósticos, y concordancia con los protocolos y redes de derivación local, para posteriormente aprobar o rechazar la interconsulta. El profesional contralor es también coordinador de la gestión interna de las interconsultas que han sido rechazadas. El objetivo de esta revisión es mejorar la pertinencia de las derivaciones a especialidad y optimizar el uso de los recursos disponibles.” (...) “El contralor es quien coordina, además, la gestión interna de interconsultas cuando éstas han sido rechazadas por el profesional priorizador en el nivel secundario”*
- ❖ **Priorizador:** *“Médico u Odontólogo especialista responsable de verificar la correcta derivación de la SIC a la especialidad de acuerdo a protocolos existentes, confirmando su destino y asignando prioridad” (...) “El priorizador tendrá para cada solicitud las siguientes alternativas: Aceptar y priorizar, Crear orden de atención, Solicitar redirección, y Gestionar en origen.”*

Nota: Para ambos casos también se puede delegar la función por parte del Establecimiento, respaldado y supervisado por el Estamento correspondiente.

Conforme a las funciones mencionadas, se definieron las horas máximas semanales para contralor de 5 horas semanales y para priorizador de 1 hora semanal.

Profesionales que dan apoyo a una especialidad

A todo profesional se le debe programar lo que está produciendo, independiente si cuenta o no con la especialidad en la que se desempeña. De acuerdo a ello su jerarquía en agenda medica debe concordar con lo que se le programa al médico, de este modo su producción se tributará correctamente y existirá correlación, mostrando el cumplimiento real.

En el caso de los Médicos Generales que dan apoyo a una especialidad, es imperativo tener una resolución en la cual se da el respaldo legal de las actividades que pueda realizar. A continuación, se presenta un ejemplo de su programación.

1. En la planilla de RRHH debe quedar ingresado como “sin especialidad registrada”:

RUT_TIT	DV_TIT	Ausentismo (SI/NO)	Motivo (maternales, PSGS, Comisiones de estudio)	RUT Programable	DV	Nombre	LEY	Correlativo Contrato	Título Profesional desempeño	Especialidad SIS	Hrs Semanales contratada	Horas efectivas al centro
		No					19.664	1	Médico(a) Cirujano(a)	Sin especialidad Registrada	44	44

2. En Planilla de programación médica se le debe ingresar la especialidad que apoya, indicando “Si” en la columna “M. General”:

Especialidad	Id_Actividad	Actividad	Horas asignadas	Rendimiento por Hora	Total Horas semanales del contrato	% asignado del contrato	Total horas semanales contratadas	Delta contrato vs program	Producción 1 Sem	Producción 2 Sem	M. General
MEDICINA INTERNA	2	Consulta Control de especialidad Presencial	0,65	3	19,5	3%	44	0	-	30	Si
MEDICINA INTERNA	1	Consulta Nueva de especialidad Presencial	15,1	4	19,5	77%	44	0	-	930	Si
MEDICINA INTERNA	2	Consulta Control de especialidad Presencial	22	3	22	100%	44	0	-	1.214	Si
MEDICINA INTERNA	400	Visita a sala Hospitalizado cama media Adulto	3,75	2	19,5	19%	44	0	-	116	Si

3. Su producción de consultas y controles se debe tributar al REM 07 en la última columna “Consultas de Especialidades resueltas por Médico General”:

CONSULTAS NUEVAS SEGÚN ORIGEN								Consultas de Especialidades resueltas por Médico General	
Menores 18 años				De 18 y más años				Menor 18 años	De 18 y más años
Total	APS	CAE/CDT/CRS/Hospitalización	Urgencia	Total	APS	CAE/CDT/CRS/Hospitalización	Urgencia		
2768	2031	638	99	6	6	0	0	0	0
85	60	23	2	5473	4178	1214	81	0	2446

Es responsabilidad del establecimiento informar a referente de programación de la DSSAS, quienes son los profesionales que apoyan a una especialidad, para solicitar el respectivo cambio en Agenda médica.

Plan de trabajo con las especialidades priorizadas

Especialidades priorizadas:

- Ginecología
- Medicina Interna
- Neurología
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Traumatología y Ortopedia

Para asegurar una gestión efectiva con las especialidades priorizadas, se establecieron puntos críticos de mejora, definidos por visitas ministeriales. Es por ello que es indispensable implementar los puntos del siguiente plan de trabajo:

1. Todos los profesionales de las especialidades mencionadas deben estar al tanto de su programación. En primera instancia se deberá remitir a referente de programación lista de participación de las jefaturas de las especialidades priorizadas (Ver anexo Formatos N°6). Para la primera reprogramación, está lista se extenderá a los profesionales, de modo que se logre el 100% del objetivo.
2. Concordancia entre agenda médica y programación. Se enviará un informe mensual breve con el cruce de horas efectivas v/s las programadas. En caso de presentar diferencias la jefatura de la especialidad deberá presentar justificación al encargado de programación, quien a su vez deberá enviar a referente del Servicio.
3. SDM deberá realizar un acompañamiento continuo a las jefaturas directas, además de un monitoreo mensual de la producción por especialidad y profesional en conjunto a referente de programación del Servicio de Salud.

Nota: en caso de existir modificaciones en la programación de un profesional en un periodo distinto a la etapa de programación/reprogramación esto deberá ser informado formalmente a la Dirección de Servicio y deberá estar sujeto a las necesidades sanitarias y prioridades del establecimiento.

Otras directrices

- Solo se pueden programar comités a aquellos profesionales que estén respaldados por resolución.
- Solo los establecimientos que tengan pabellón de urgencia, pueden programar la actividad.
- Si es conocido que un profesional tiene algún tipo de ausentismo (Comisión de servicio, Comisión de estudio, entre otros) y aún no se realiza el trámite administrativo, se le debe programar de acuerdo a su realidad, independiente del atraso en la gestión.
- La actividad "Gestión de Camas" solo la pueden programar los profesionales que tengan el cargo de gestión de pacientes.

Ítem II “Material de apoyo”

OOTT 2026 y Recomendaciones programáticas específicas (RPE)

- Orientaciones para la planificación y programación en red 2025 **(Se mantiene versión año 2025)**
- RPE N°9 Criterios técnicos para programación de actividades por telemedicina en Atención primaria, secundaria y terciaria.
- RPE N°11 Criterios técnicos para la programación de prestaciones de salud mental en APS y atención abierta de especialidad. **(Nueva versión)**
- RPE N°14 Criterios técnicos para programación actividades de rehabilitación Atención primaria, secundaria y terciaria. **(Nueva versión)**
- RPE N°16 Criterios técnicos para la programación de atenciones de infancia en atención primaria, secundaria y terciaria. **(Nueva versión)**
- RPE N°20 Criterios técnicos para programación de actividades de QFs en atención primaria, secundaria y terciaria.
- RPE N°21 Criterios técnicos programación atención ambulatoria especialidades. **(Nueva versión)**
- RPE N°22 Criterios técnicos para programación actividades salud sexual y reproductiva en atención secundaria y terciaria. **(Nueva versión)**
- RPE N°23 Criterios técnicos para la programación de atención cerrada de salud mental. **(Nueva versión)**
- RPE N°24 Criterios técnicos para la programación de unidades oncológicas.
- RPE N°25 Criterios técnicos para programación de actividades de CPU en atención primaria, secundaria y terciaria. **(Nueva versión)**
- RPE N°26 Criterios técnicos para medicina nuclear en nivel terciario.
- RPE N°27 Criterios técnicos para imagenología en nivel secundario y terciario.
- RPE N°28 Criterios técnicos del programa de atención y control en infecciones de transmisión sexual ITS nivel secundario. **(Nueva versión)**
- RPE N°29 Criterios técnicos para el proceso de programación de comités y comisiones en redes de alta complejidad.
- RPE N°30 Criterios técnicos para la programación de la urgencia Gineco Obstétrica UGO.
- RPE N°32 Cirugías mayores y mayores ambulatorias.
- RPE N°35 Criterios técnicos para programación de equipos especializados programa de reparación y atención integral PRAIS.
- RPE N°36 Glosario de actividades clínicas programables en la atención ambulatoria de especialidades **(Nueva incorporación)**

Se adjunta link de acceso a carpeta con las orientaciones de Minsal ["Recomendaciones programáticas específicas"](#)

Glosario rendimiento normado por DSSAS

De acuerdo a las actividades disponibles a programar y que no cuentan con rendimiento entregado por Minsal, se elaboró una estandarización ajustada a todos los establecimientos. Esto fue desarrollado con la participación de los referentes de las especialidades y no médicos.

Esta herramienta la pueden encontrar en [Link con acceso a glosario de rendimientos DSSAS](#)

Lista de contactos con referencias involucradas en programación

Con el fin de mejorar las líneas de comunicación con los actores involucrados en el proceso se adjunta link con acceso a [Excel "Contacto de referencias"](#)



Se adjunta código Qr y [Link](#) con acceso a carpeta “Herramientas de apoyo”, la cual contiene los archivos mencionados

Ítem III “Calendarización año 2026”

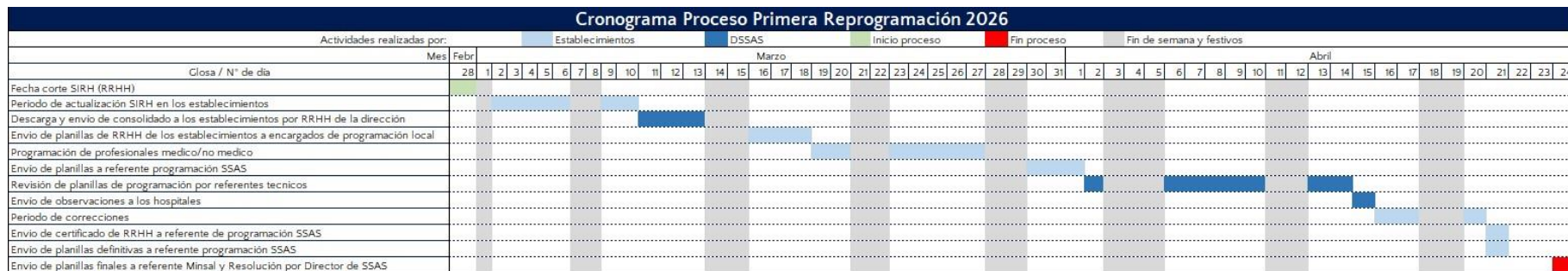
Programación inicial 2026

- Fecha de corte: 31-10-2025
- Fecha de envío a Minsal: 19-12-2025



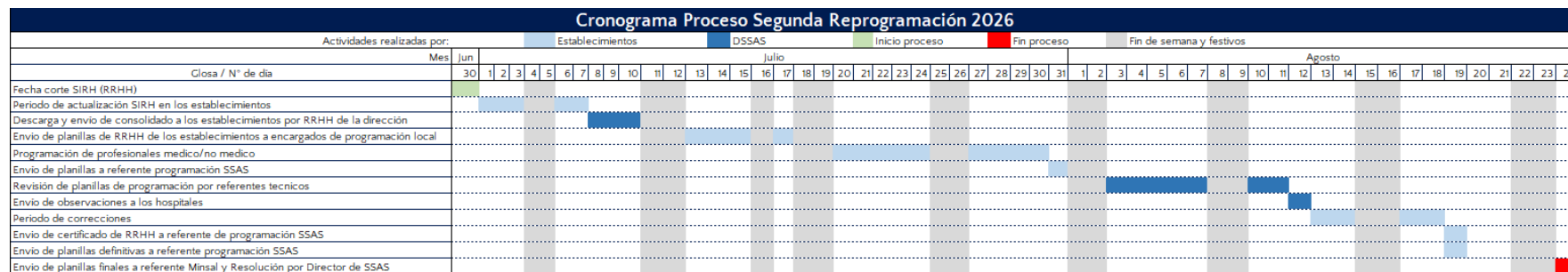
Primera Reprogramación 2026

- Fecha de corte: 28-02-2026
- Fecha de envío a Minsal: 24-04-2026



Segunda Reprogramación 2026

- Fecha de corte: 30-06-2026
- Fecha de envía a Minsal: 24-08-2026



De acuerdo a reunión ministerial de programación – RRHH, se aplazo la fecha de descarga de la dotación, esto para dar plazo de la carga de información en SIRH por parte de los establecimientos.

Ítem IV “Anexos”

En este ítem se recopilan documentos de apoyo adicionales que tienen el fin de brindar soporte, referencia, y/o respaldo para la preparación y ejecución de la programación operativa de cada establecimiento.

Documentos de apoyo

1. Circular N° 24 – Informa tramitación ausentismo legales
2. Resolución N° 26062 - Procedimiento de Prevención, Investigación y Sanción de Acoso Laboral, Acoso Sexual, Discriminación Arbitraria y Violencia en el Trabajo SSAS. (Asignación de plazo para fiscales y actuarios - Artículo N° 23)
3. Circular N° 31 – Obligaciones jefaturas directas Servicio de Salud Araucanía Sur.
4. Protocolo de referencia y contrarreferencia

Formatos

1. Pauta de cotejo para validación de programación



Pauta de cotejo para validación de programación.
Departamento Gestión Asistencial
Servicio de Salud Araucanía Sur

Establecimiento evaluado:			
SDM establecimiento:			
Proceso evaluado:		Fecha revisión:	

Objetivo
Verificar el cumplimiento de los criterios mínimo de validación de programación de los establecimientos de mediana y alta complejidad de la red asistencial.

ÍTEM	Criterios Mínimos	Cumple	Observación
1.	Recepción de antecedentes		
1.1	SDM Envía planilla en formato y tiempo.		
1.2	Envío de actas y lista de asistencia de reuniones del comité de programación.		
1.3	Envío de Certificado de RRHH en formato y tiempo.		
1.4	Envío de lista de participación de jefatura de especialidades priorizadas.		
2.	Revisión planilla de programación		
2.1	Validación por referencias técnicas de la DSSAS.		
2.2	Verificación de rendimientos en especialidades con acuerdos.		
2.3	Correcciones realizadas y/o justificaciones enviadas.		
2.4	Programación de MG de acuerdo a QOTT.		
3.	Responsabilidades en el proceso		
3.1	Envío de documento de compromiso de programación por Director y SDM.		

ÍTEM	Criterios sugeridos*	Cumple	Observación
1.	Programación de actividades trazadoras.		
2.	Porcentaje de horas asignadas al proceso ambulatorio por especialidad.		
3.	Cumplimiento del 100% de las QOTT ministeriales y DSSAS.		

Estado de Validación:

Firma SDM DSSAS

* Estos criterios no son de carácter obligatorio para este proceso, por ende, no influyen en la validación de su planilla de programación. Sin embargo, se espera que los consideren.

2. Comité

 Servicio de Salud Araucanía Sur
Departamento Gestión Asistencial

Anexo complementario de comité de programación

De acuerdo con ORD N° 3108, el Comité de programación local deberá estar integrado al menos por funcionarios de los siguientes ámbitos:

- Subdirector/a Médico
- Referente de Programación
- Referente de Recursos Humanos y/o Subdirección de gestión y desarrollo de las personas.
- Referente de Estadística
- Referente de Control de gestión
- Referente de Agendamiento y/o proceso ambulatorio
- Referente Proceso quirúrgico y/o atención cerrada
- Referentes ligados al área de procesos clínicos y/o gestión clínica.

Nota: En caso de que el establecimiento estime pertinente la incorporación de más actores queda a disposición local.

Nombre profesional	Rut	DV	Cargo

3. Certificado de RRHH

 Servicio de Salud Araucanía Sur
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Estimado Sr(a): XXX Referente de programación médica, no médica de la dirección de Servicio de Araucanía Sur, adjunto planilla del universo de profesionales sujetos de estudio, con contrato vigente al 00.00.0000, cuyo resumen se presenta a continuación.

Título Profesionales	N° de Registro Contractual
Médico(a) Cirujano(a)	
Bioquímico(a)	
Químico(a) – Farmacéutico(a)	
Enfermero(a)	
Matrón(a)	
Fonoaudiólogo(a)	
Tecnólogo(a) Médico(a)	
Nutricionista	
Terapeuta Ocupacional	
Kinesiólogo(a)	
Psicólogo(a) Clínica	
Asistente Social	
Psicopedagogo(a)	
Total registros	

Los antecedentes remitidos se encuentran debidamente registrados en el SIRH, para control y seguimiento posterior a realizar por el nivel central.

Nombre y timbre
Jefe Dpto. de Gestión y Desarrollo de las Personas del establecimiento

Temuco, XX de XXXX del XXXX

4. Compromiso de programación

Resumen producción de actividades evaluadas en COMGES 1.3
"Insertar Establecimiento"

Actividades Componente A - Programación médica

Especialidad	C. Nuevo	C. Control	Especialidad	C. Nuevo	C. Control
Anestesiología			Medicina Familiar		
Cardiología Adulto			Psiquiatría		
Cardiología Pediátrica			Medicina Interna		
C. Cardiovascular			Medicina Patológica		
C. Cabeza, Cuello y Maxilofacial			Neftrología Adulto		
C. Digestiva (Alta)			Neftrología Pediátrica		
C. General Adulto			Neonatólogía		
C. Pediátrica			Neurocirugía		
C. Plástica y Reparadora			Neurología Adulto		
C. Tórax			Neurología Pediátrica		
C. Vascular Periférica			Neumología		
Coloproctología			Nutriólogo Adulto		
Dermatología			Nutriólogo Pediátrico		
Diabetología			Oftalmología		
Endocrinología Adulto			Oncología Médica		
Endocrinología Pediátrica			Otorrinolaringología		
Broncopulmonar Adulto			Pediatría		
Broncopulmonar Pediátrica			Prostata Adulto		
Gastroenterología Adulto			Prostata Pediátrica		
Gastroenterología Pediátrica			Radioterapia onco		
Genética clínica			Reumatología Adulto		
Geriatría			Reumatología Pediátrica		
Ginecología Adulto			Traumatología Adulto		
Hematología Adulto			Traumatología Pediátrica		
Hemato-oncología Pediátrica			Urología Adulto		
Infectología Adulto			Urología Pediátrica		
Infectología Pediátrica					
Maxilofacial					

Nota: Se consideran atenciones presenciales y por telemedicina

Actividades Componente B - Programación no médica

Profesión	Consultas	Salud Mental	HD	Procedimientos	Farmacia	Rehabilitación
Asistente Social						
Enfermería						
Fonoaudiología						
Genesicología						
Matrona						
Nutricionista						
Psicología Clínica						
Químico-Farmacéutico						
Tecnología Médica						
Terapeuta Ocupacional						

Actividades Componente C - Programación médica

Proceso	Procedimientos
Procedimientos/Informes	
HD	
Crucios Electivos	
Crucios Hospitalarios	

Nombre y firma Director _____
Nombre y firma SDM _____

5. Informe de justificación

Servicio de Salud Araucanía Sur
Departamento Gestión Asistencial

Informe de justificación

Este informe tiene como finalidad presentar las justificaciones que su hospital debe proporcionar ante la falta de modificaciones en la programación, a pesar de las observaciones emitidas por los referentes de la DSSAS. A través de estas explicaciones, se busca transparentar las razones que impiden la implementación de los ajustes sugeridos, garantizando así un proceso de revisión riguroso y fundamentado, que contribuya a la mejora continua de la gestión hospitalaria.

A continuación, se presenta desglose por cada observación a justificar del Hospital _____ bajo la responsabilidad del Director(a) _____ y SDM _____

Observación realizada	Justificación	¿Adjunta respaldo?

Nombre y firma Director(a) _____
Nombre y firma SDM _____
Ciudad, XX de XX del XXXX

6. Lista de participación de jefaturas

Lista de participación de jefaturas en
programación de especialidades prioritizadas

Nombre del establecimiento:				
Proceso de programación:				
Responsable del proceso (SDM):				

Especialidad priorizada	Nombre jefatura	N° de personas a su cargo	Fecha de reunión con SDM	Firma jefatura

 Nombre y firma SDM

Ciudad, XX de XX del XXXX

7. Pauta de revisión para Referente Técnicos de DSSAS



GOBIERNO DE TUCUMÁN

Pauta de cotejo para revisión y validación de referencia técnica

Departamento Gestión Asistencial

Servicio de Salud Araucanía Sur

Establecimiento evaluado:			
Referencia Técnica			
Proceso evaluado:		Fecha revisión:	

Objetivo

Revisar planillas de programación de los establecimientos de la red, brindando apoyo por medio de observaciones que permitan la optimización de recursos con una planificación eficiente.

ÍTEM	Criterio de evaluación	Cumple
1.	Contraparte en el establecimiento participo de la programación	
2.	Los rendimientos se ajustan a la norma ministerial	
3.	Programación de actividades es pertinente al desarrollo del estamento	

Observaciones a incorporar en informe

Estado revisión: